

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Apostila de Estudo · SESSÃO 07

Neoplasias Digestivas e Ostomias

Câncer de esôfago, gástrico e colorretal; cuidados com ostomias



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental

UnibH Vespasiano

8º PERÍODO · 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

SUMÁRIO

Suspeitar, confirmar com biópsia, estadiar e só então tratar

I	Câncer de esôfago	3
	<i>Carcinoma escamoso × adenocarcinoma, disfagia, estadiamento e tratamento por estágio</i>	
II	Câncer gástrico	5
	<i>H. pylori, Lauren e Borrmann, sinais de doença avançada, margens e linfadenectomia D2</i>	
III	Câncer colorretal	7
	<i>Rastreamento no SUS, cólon direito × esquerdo × reto, cólon × reto no tratamento, urgência</i>	
IV	Ostomias: a prática da aula	10
	<i>Tipos, demarcação, estoma normal, complicações e troca da bolsa passo a passo</i>	
V	Armadilhas e sequência mental	12
	<i>Erros comuns e o raciocínio em 30 segundos</i>	
—	Pontos clássicos de prova	13
	<i>Epônimos e classificações que ainda caem</i>	
—	Referências e créditos das imagens	14

COMO LER ESTA APOSTILA

CAI NA PROVA

O que costuma ser cobrado ou confundido.

CONDUTA

O passo a passo do que fazer.

ATENÇÃO

Armadilha clínica ou mudança recente.

CAPÍTULO I

Câncer de esôfago

Disfagia progressiva com emagrecimento é câncer de esôfago até prova em contrário. Quando ela aparece, a luz já está muito reduzida e a doença costuma estar avançada.

São dois tumores diferentes que dividem o mesmo órgão. O **carcinoma escamoso** (espinocelular) vem do epitélio do próprio esôfago. O **adenocarcinoma** nasce da metaplasia intestinal do esôfago de Barrett, consequência do refluxo crônico. O tabagismo é fator de risco comum aos dois.

TABELA 1. Os dois tipos histológicos

	CARCINOMA ESCAMOSO	ADENOCARCINOMA
<i>Fatores de risco</i>	Tabaco e álcool (efeito sinérgico), bebidas muito quentes, acalasia (inclusive chagásica), estenose por cáustico, tilose	Refluxo crônico, esôfago de Barrett, obesidade, tabaco
<i>Localização</i>	Terços superior e médio	Terço distal e junção esofagogástrica
<i>Perfil típico</i>	Homem, etilista e tabagista, baixa renda	Homem branco, obeso, com refluxo de longa data
<i>Tendência</i>	Ainda o mais comum no Brasil	Crescendo no Ocidente, junto com a obesidade

São tendências, não regras: um escamoso pode ser distal e um adenocarcinoma pode surgir sem Barrett conhecido.

Clínica

A **disfagia** começa para sólidos e progride para pastosos e líquidos em semanas a meses. Vem com perda de peso rápida, às vezes odinofagia e anemia. Rouquidão sugere invasão do nervo laríngeo recorrente. Tosse ao engolir e pneumonias de repetição sugerem **fístula traqueoesofágica**: é doença irremediável.

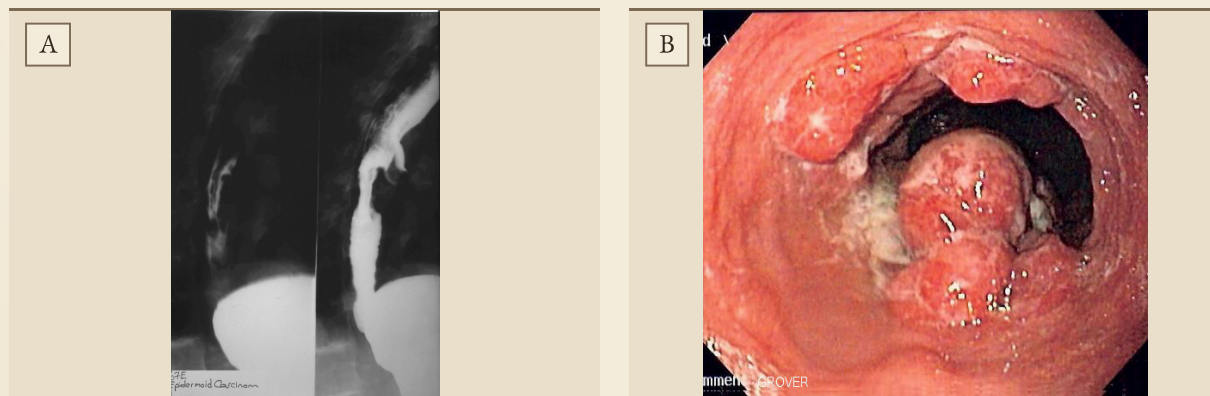


FIGURA 1. (A) Esofagograma contrastado: estreitamento irregular, com bordas abruptas ("degrau") e mucosa destruída, típico de tumor. (B) Endoscopia: adenocarcinoma vegetante e friável na junção esofagogástrica.

(A) Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0 · (B) Samir, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Diagnóstico e estadiamento

O exame que confirma é a **endoscopia digestiva alta com biópsia**. O esofagograma pode sugerir o tumor, mas não substitui a histologia. Com o diagnóstico, estadie: a **TC de tórax e abdome** procura metástases; a **ecoendoscopia** é o melhor exame para a profundidade (T) e os linfonodos regionais (N); o **PET-CT** acha metástases ocultas que a TC não mostrou. Nos tumores do esôfago superior e médio, a broncoscopia avalia invasão da via aérea.

TABELA 2. O tratamento segue o estágio

ESTÁDIO	CONDUTA
<i>Restrito à mucosa (T1a), pequeno e sem invasão linfovascular</i>	Ressecção endoscópica (mucosectomia ou dissecação submucosa)
<i>T1b a T2, sem linfonodo (N0)</i>	Esofagectomia; alguns serviços fazem neoadjuvância no T2
<i>Localmente avançado: T3–T4a ou linfonodo positivo, M0</i>	Tratamento neoadjuvante seguido de esofagectomia. Escamoso: quimiorradioterapia (esquema CROSS). Adenocarcinoma: quimioterapia perioperatória (FLOT) ou quimiorradioterapia
<i>Escamoso do esôfago cervical</i>	Quimiorradioterapia definitiva, porque a cirurgia exigiria retirar a laringe
<i>T4b (aorta, traqueia, vértebra), sem metástase</i>	Quimiorradioterapia definitiva, ainda com intenção curativa
<i>Metastático (M1)</i>	Tratamento sistêmico e alívio da disfagia: prótese esofágica, radioterapia, via alimentar (gastrostomia ou jejunostomia)

Fontes: van Hagen et al., NEJM 2012 (CROSS); Hoepfner et al., NEJM 2025 (ESOPEC).

ATENÇÃO · MUDOU EM 2025

No **adenocarcinoma** localmente avançado, o estudo ESOPEC comparou a quimioterapia perioperatória FLOT com a quimiorradioterapia do CROSS, e o FLOT teve maior sobrevida. Por isso, muitos serviços passaram a preferir o FLOT no adenocarcinoma. No **escamoso**, a quimiorradioterapia continua sendo a base. Mesmo com resposta completa à neoadjuvância, o padrão ainda é operar; a vigilância sem cirurgia é estudada em centros selecionados (estudo SANO). Se sobrar tumor na peça após quimiorradioterapia, o nivolumabe adjuvante é opção (CheckMate 577).

Vias de esofagectomia: trans-hiatal (abdome e pescoço, sem toracotomia), Ivor Lewis (abdome e tórax, anastomose torácica: a fístula causa mediastinite) e McKeown (abdome, tórax e pescoço, anastomose cervical). O estômago em tubo substitui o esôfago.

CAI NA PROVA

Disfagia progressiva + emagrecimento: **endoscopia com biópsia**. Escamoso: **tabaco e álcool, terço médio**. Adenocarcinoma: **Barrett e obesidade, terço distal**. Fístula para a via aérea e invasão da aorta tornam o tumor irressecável.

CAPÍTULO II

Câncer gástrico

Quase todo câncer gástrico é adenocarcinoma, e o principal fator de risco é o *Helicobacter pylori*. Dispepsia com sinal de alarme pede endoscopia.

Fatores de risco: *H. pylori* (gastrite crônica → atrofia → metaplasia intestinal → displasia → câncer), dieta rica em sal e alimentos defumados ou conservados, tabagismo, gastrite atrófica autoimune (anemia perniciosa), gastrectomia prévia, pólipos adenomatosos e história familiar. A mutação do gene **CDH1** causa o câncer gástrico difuso hereditário.

Sinais de alarme da dispepsia: idade de início mais alta, perda de peso, disfagia, vômitos persistentes, anemia ou sangramento digestivo, massa palpável e história familiar de câncer gástrico.

TABELA 3. Classificação de Lauren

	INTESTINAL	DIFUSO
<i>Origem</i>	Passa pela metaplasia intestinal; ligado ao <i>H. pylori</i> e ao ambiente	Sem metaplasia prévia; componente genético (CDH1)
<i>Microscopia</i>	Forma glândulas, bem diferenciado	Células soltas em anel de sinete
<i>Paciente</i>	Mais velho, homem	Mais jovem, ambos os sexos
<i>Disseminação</i>	Hematogênica (fígado)	Pela parede e pelo peritônio; pode virar linite plástica
<i>Prognóstico</i>	Melhor	Pior

Sinais que sugerem doença disseminada (precisam de confirmação, mas, confirmados, afastam a cirurgia curativa): linfonodo supraclavicular esquerdo (**Virchow**), linfonodo axilar esquerdo (**Irish**), nódulo umbilical (**Irmã Maria José**), implante no fundo de saco palpável ao toque retal (**prateleira de Blumer**), metástase ovariana (**Krukenberg**) e ascite com carcinomatose.

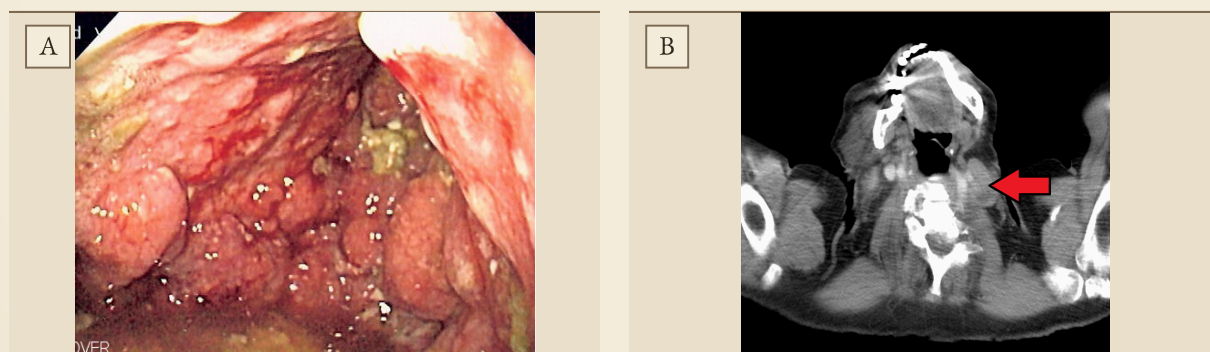


FIGURA 2. (A) Endoscopia: estômago tomado por tumor infiltrativo e ulcerado, com parede rígida (linite plástica, Borrmann IV). (B) TC do pescoço: linfonodo supraclavicular esquerdo aumentado, o linfonodo de Virchow (seta).

(A) Samir, CC BY-SA 3.0 · (B) James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Diagnóstico e estadiamento

Endoscopia com múltiplas biópsias, descrevendo a distância até a cárdia e o piloro. Estadie com **TC de tórax, abdome e pelve**. Nos tumores avançados candidatos a tratamento, a **laparoscopia diagnóstica com lavado peritoneal** procura implantes que a TC não enxerga; **citologia do lavado positiva já é M1**, mesmo sem implante visível. A ecoendoscopia ajuda a decidir entre ressecção endoscópica e cirurgia no tumor inicial. Câncer gástrico **precoce** é o restrito à mucosa ou à submucosa, com ou sem linfonodo.

TABELA 4. Do tumor inicial ao avançado

SITUAÇÃO	CONDUTA
<i>Adenocarcinoma diferenciado, restrito à mucosa (T1a), ≤ 2 cm, sem úlcera</i>	Ressecção endoscópica (mucosectomia ou dissecação submucosa)
<i>Tumor ressecável, cT2 ou mais, ou linfonodo positivo</i>	Gastrectomia com linfadenectomia D2. No Ocidente e no Brasil, em paciente apto, soma-se a quimioterapia perioperatória (FLOT)
<i>Tumor distal (antro)</i>	Gastrectomia subtotal, se a margem proximal for suficiente
<i>Tumor proximal, ou margem insuficiente</i>	Em geral, gastrectomia total com reconstrução em Y de Roux; gastrectomia proximal em casos iniciais selecionados
<i>Metastático ou irressecável</i>	Tratamento sistêmico. Obstrução: gastrojejunostomia ou prótese. Sangramento: endoscopia ou radioterapia

Fontes: endoscopia, margens e D2: diretriz japonesa, 7ª ed. (JGCA 2025). Quimioterapia perioperatória: Al-Batran et al., Lancet 2019 (FLOT4); a diretriz japonesa não a adota como padrão.

MARGEM PROXIMAL MACROSCÓPICA

T1: 2 cm. **T2 ou mais, crescimento expansivo** (Borrmann I e II): 3 cm. **Infiltrativo** (Borrmann III e IV): 5 cm. Na dúvida, congelação da margem. O objetivo é a ressecção R0, sem tumor na margem.

LINFADENECTOMIA

D2 no tumor cT2 ou mais, ou com linfonodo positivo: retira os perigástricos e os do tronco celíaco e seus ramos. D1 ou D1+ no tumor inicial que não cabe na endoscopia. Examine pelo menos **16 linfonodos**. Não retire o baço de rotina.

ATENÇÃO · CUIDADO COM A "MARGEM DE 6 CM"

Muitos materiais ainda ensinam "margem de 6 cm". A diretriz japonesa usa **3 cm** para o tumor expansivo e **5 cm** para o infiltrativo desde 2010, e manteve esses valores na edição de 2025.

Outros tumores do estômago

Linfoma MALT: associado ao *H. pylori*; o primeiro tratamento é **erradicar a bactéria**, não operar. **GIST:** tumor das células intersticiais de Cajal, marcador **CD117 (KIT)**; ressecção com margem livre, **sem linfadenectomia**; imatinibe no tumor de alto risco ou metastático.

CAPÍTULO III

Câncer colorretal

É um dos cânceres mais frequentes no Brasil e quase sempre nasce de um pólio adenomatoso. Por isso o rastreamento salva vidas: tirar o pólio previne o câncer.

Fatores de risco: idade (o principal), história pessoal ou familiar de câncer colorretal ou adenoma, doença inflamatória intestinal, síndromes hereditárias (polipose adenomatosa familiar e síndrome de Lynch), obesidade, sedentarismo, carne processada, álcool e tabaco.

ATENÇÃO · MUDOU EM MAIO DE 2026 · RASTREAMENTO NO SUS

O SUS adotou o **teste imunoquímico fecal (FIT)** como exame de referência para pessoas **assintomáticas de 50 a 75 anos** com risco habitual. Teste positivo: **colonoscopia**. Rastreamento é para quem não tem sintomas. Quem tem sangramento, anemia ou mudança do hábito intestinal vai direto para a investigação. Diretrizes estrangeiras começam aos 45 anos, mas essa não é a regra do SUS. **Alto risco** (parente de 1º grau com câncer colorretal, síndrome hereditária, doença inflamatória intestinal) não entra no FIT: tem avaliação própria, em geral com colonoscopia mais cedo.

TABELA 5. A clínica muda com o lado

LOCAL	APRESENTAÇÃO TÍPICA	POR QUÊ
<i>Cólon direito</i>	Anemia ferropriva, fraqueza, massa palpável; raramente obstrui	Luz larga e fezes ainda líquidas
<i>Cólon esquerdo</i>	Mudança do hábito intestinal, fezes afiladas, sangue nas fezes, cólica, obstrução	Luz estreita e fezes sólidas; tumor anelar ("maçã mordida")
<i>Reto</i>	Sangramento vivo, tenesmo , puxo, fezes com muco	Tumor palpável ao toque retal

Anemia ferropriva em homem ou em mulher após a menopausa pede investigação do tubo digestivo.

Diagnóstico e estadiamento

Colonoscopia completa com biópsia: confirma e procura tumor ou pólio sincrônico no restante do cólon. Estadie com **TC de tórax, abdome e pelve** e dosagem do **CEA**. No reto, a **ressonância da pelve** mostra a invasão local, os linfonodos e a distância do tumor à fáscia do mesorreto (margem circunferencial), e orienta a neoadjuvância. Pesquise também a **instabilidade de microssatélites (MMR/MSI)**: o tumor com deficiência de reparo pode responder à imunoterapia. O CEA não faz diagnóstico: serve para prognóstico e seguimento.

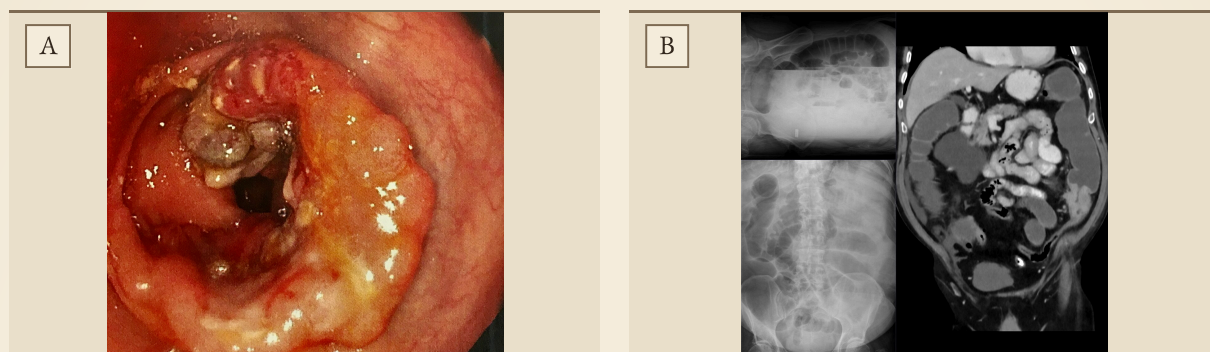


FIGURA 3. (A) Colonoscopia: tumor ulcerado e vegetante que estreita a luz do cólon. (B) Obstrução por tumor estenosante do cólon descendente: na radiografia, cólon distendido com níveis; na TC coronal, cólon dilatado até o ponto da estenose.

(A) Dr. Gannavarapu Narasimhamurthy, CC0 · (B) Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

TABELA 6. Cólon e reto não se tratam igual

	CÓLON	RETO MÉDIO E BAIXO
<i>Primeiro passo</i>	Cirurgia	Depende da RM: T3–T4 ou linfonodo positivo recebe neoadjuvância antes
<i>Cirurgia</i>	Colectomia do segmento com ligadura dos vasos na origem e seu mesentério	Ressecção com excisão total do mesorreto : ressecção anterior baixa ou amputação abdominoperineal
<i>Margem</i>	Cerca de 5 cm de cada lado	Distal de 1–2 cm (1 cm pode bastar no reto baixo após neoadjuvância)
<i>Linfonodos</i>	Examinar pelo menos 12 para estadiar com segurança	
<i>Depois da cirurgia</i>	Quimioterapia adjuvante no estágio III (e no II de alto risco)	Conforme a resposta e o tratamento feito antes

Fontes: ASCRS, diretrizes de câncer de cólon (2022) e de reto (2023).

Amputação abdominoperineal (Miles): retira reto e ânus e deixa **colostomia definitiva**; é indicada quando o tumor invade o esfíncter ou não há margem distal. **Ressecção anterior baixa:** preserva o esfíncter; costuma vir com **ileostomia de proteção** temporária, sobretudo após radioterapia. No reto, quem tem resposta clínica completa à neoadjuvância pode, em centro preparado, seguir em vigilância rigorosa sem operar ("watch and wait").

CAI NA PROVA

Metástase hematogênica vai primeiro ao **fígado**, pela veia porta. O **reto distal** pode mandar metástase direto ao **pulmão**, pelas veias retais inferiores, que drenam na cava. Metástase hepática ressecável **pode ser operada com intenção curativa**.

Câncer colorretal na urgência

Muitos pacientes chegam ao pronto-socorro já obstruídos ou perfurados, e o tumor é descoberto na cirurgia. A conduta depende do lado, da estabilidade e do estado do intestino.

TABELA 7. Obstrução e perfuração

CENÁRIO	CONDUTA HABITUAL
Obstrução do cólon direito ou transverso	Colectomia direita (ou estendida) com anastomose primária ileocólica
Obstrução do cólon esquerdo, paciente estável	Ressecção com anastomose, com ou sem estoma de proteção; prótese endoscópica como ponte até a cirurgia eletiva; ou estoma descompressivo
Obstrução esquerda com instabilidade, peritonite ou alça sem condição	Cirurgia de Hartmann : ressecção, colostomia terminal e coto retal fechado
Obstrução por tumor de reto médio ou baixo, sem perfuração	Estoma derivativo (colostomia em alça), sem ressecar; depois estadiamento e neoadjuvância
Perfuração	Cirurgia de urgência, ressecção do segmento; Hartmann é comum quando há peritonite fecal

ATENÇÃO · O CECO QUE VAI ROMPER

Com a **válvula ileocecal competente**, o cólon obstruído vira uma alça fechada: o gás não volta para o delgado. O ceco, o segmento mais largo, é o que mais distende e perfura. Ceco muito dilatado na imagem (classicamente acima de 12 cm), com dor localizada na fossa ilíaca direita, pede descompressão urgente.



FIGURA 4. TC coronal: fígado tomado por metástases de câncer de cólon, e tumor no cólon (seta). O fígado é o primeiro destino das metástases porque recebe o sangue do intestino pela veia porta.

James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

CAI NA PROVA · HARTMANN NÃO É RESPOSTA AUTOMÁTICA

No cólon esquerdo obstruído, Hartmann é a saída para o paciente **instável** ou **com peritonite**. No estável, ressecção com anastomose ou prótese como ponte também são válidas. No **reto médio ou baixo** obstruído e sem perfuração, não se resseca na urgência: **deriva** e trata depois.

CAPÍTULO IV

Ostomias: a prática da aula

Estomia é a exteriorização de uma víscera oca na pele. A boa estomia começa antes da cirurgia, com a demarcação, e continua com a pele periestomal íntegra.

TABELA 8. Os tipos que você precisa reconhecer

	COLOSTOMIA	ILEOSTOMIA	UROSTOMIA
Onde fica	Em geral à esquerda (descendente ou sigmoide)	Em geral à direita (íleo terminal)	À direita (conduto ileal de Bricker)
Efluente	Fezes pastosas a formadas	Líquido, contínuo e rico em enzimas	Urina, contínua
Altura	Pouco acima da pele	Protrusa, 2–3 cm, para o líquido cair longe da pele	Protrusa
Risco principal	Hérnia paraestomal, prolapso	Dermatite e desidratação pelo alto débito	Infecção urinária, dermatite

Terminal (uma boca) × **em alça** (duas bocas, em geral temporária, para proteger uma anastomose). **Temporária** × **definitiva** (após amputação abdominoperineal).

DEMARCAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

Feita antes da cirurgia eletiva, de preferência pelo estomaterapeuta. O local fica **sobre o músculo reto abdominal**, numa área plana, **visível para o próprio paciente**, longe de pregas, cicatrizes, umbigo, cintura da roupa e proeminências ósseas. Teste com o paciente **em pé, sentado e deitado**.

ESTOMA NORMAL

Vermelho vivo ou rosado, úmido e brilhante, como a mucosa da boca. É indolor ao toque e sangra um pouco com facilidade. Fica edemaciado nas primeiras semanas e diminui depois: **meça de novo a cada troca** nesse período. Escuro, arroxeado ou preto é isquemia: avise o cirurgião.



FIGURA 5. (A) Ileostomia saudável: mucosa vermelha, úmida, protrusa, com pele ao redor íntegra. (B) Colostomia com grande hérnia paraestomal, a complicação tardia mais comum: o abaulamento ao redor do estoma descola a placa e causa vazamento.

(A) Salicyna, CC BY-SA 4.0 · (B) Mikael Häggström, CC0 · Wikimedia Commons

TABELA 9. *Complicações das estomias*

QUANDO	COMPLICAÇÃO	O QUE RECONHECER E FAZER
<i>Precoces</i>	Isquemia e necrose	Mucosa escura ou preta; se ultrapassar a fáscia, reoperar
	<i>Retração e separação mucocutânea</i>	Estoma afundado ou pele descolada; placa convexa, curativo da ferida
	<i>Dermatite periestomal</i>	A mais frequente; quase sempre vazamento ou recorte largo: corrigir a causa
	<i>Alto débito (ileostomia)</i>	Acima de cerca de 1,5 L/dia: perda de água, sódio e magnésio, desidratação e insuficiência renal; repor e reduzir o débito
<i>Tardias</i>	Hérnia paraestomal	Abaulamento ao redor do estoma; cinta, ajuste do equipamento ou cirurgia
	<i>Prolapso</i>	Alça que se exterioriza demais; mais em colostomia em alça
	<i>Estenose</i>	Orifício estreito, fezes afiladas, dificuldade de esvaziar
	<i>Bloqueio alimentar</i>	Ileostomia sem débito, cólica e distensão após alimento fibroso

Troca da bolsa de colostomia: o passo a passo do OSCE

- i.* Identifique o paciente, explique o procedimento, peça consentimento e garanta privacidade.
- ii.* Higienize as mãos, calce luvas e separe bolsa, medidor, tesoura, gaze, água e saco de descarte.
- iii.* Esvazie a bolsa, se preciso, e solte a placa devagar, rente à pele, enquanto a outra mão apoia a pele.
- iv.* Inspeção o **estoma** (cor, umidade, altura) e a **pele ao redor**; olhe o verso da placa retirada para ver por onde vazou.
- v.* Limpe com água morna (ou soro fisiológico) e sabão neutro, sem esfregar. Não use álcool, éter, óleo ou creme sob a placa.
- vi.* **Seque bem** a pele: placa em pele úmida não adere.
- vii.* **Meça** o estoma com o medidor (nos dois eixos, se for oval) e recorte a placa **do tamanho do estoma, com folga mínima**: sem apertar a mucosa e sem deixar pele exposta.
- viii.* Adjuvantes só com indicação: **pó** na pele úmida ou lesada (retire o excesso); **pasta ou anel** para vedar dobras e desníveis. Nenhum deles corrige uma placa mal recortada.
- ix.* Cole a placa centrada, de baixo para cima, pressionando por alguns segundos; encaixe e feche a bolsa e confira a vedação.
- x.* Descarte o material, retire as luvas e higienize as mãos. Registre o aspecto do estoma, da pele e do efluente.
- xi.* **Oriente**: esvaziar quando estiver entre **um terço e metade cheia**; trocar a placa no intervalo do fabricante e na hora se houver vazamento, ardor ou coceira (fita por cima não resolve); procurar ajuda se o estoma escurecer, doer muito ou parar de funcionar com distensão.

CAPÍTULO V

Armadilhas e sequência mental

TABELA 10. Erros comuns

ERRO	POR QUE ESTÁ ERRADO
<i>Tratar sem biópsia</i>	Imagem sugere; o diagnóstico de câncer é histológico
<i>Rastrear quem tem sintoma</i>	Sangramento, anemia ou mudança do hábito pedem colonoscopia diagnóstica, não FIT
<i>Pedir CEA para diagnosticar</i>	CEA serve para prognóstico e seguimento
<i>Tratar reto como cólon</i>	Reto médio e baixo precisa de RM de pelve; T3–T4 ou N+ recebe neoadjuvância antes
<i>Ressecar o reto obstruído na urgência</i>	A conduta é derivar e depois estadiar e tratar
<i>"D2 = tirar baço e pâncreas"</i>	D2 retira cadeias linfonodais; esplenectomia não é rotina
<i>Operar linfoma MALT</i>	O tratamento inicial é erradicar o <i>H. pylori</i>
<i>Recortar a placa larga "por segurança"</i>	A pele exposta ao efluente é a principal causa de dermatite
<i>Achar que estoma escuro "é normal no começo"</i>	Edema é normal; cor escura é isquemia e precisa de avaliação

A SEQUÊNCIA MENTAL EM 30 SEGUNDOS

- i.* Qual sintoma levou à suspeita? Disfagia, dispepsia com alarme, anemia, mudança do hábito, sangramento.
- ii.* Confirme com endoscopia ou colonoscopia **com biópsia**.
- iii.* Estadie: TC para metástase; ecoendoscopia no esôfago e no estômago; RM de pelve no reto.
- iv.* Decida pelo estágio: endoscopia no muito inicial, cirurgia, ou tratamento antes da cirurgia no localmente avançado.
- v.* Na urgência, resolva a complicação (obstrução, perfuração, sangramento) sem perder a chance de cura.
- vi.* Se houver estomia: demarque antes, cuide da pele e oriente o paciente.

COMPLEMENTO

Pontos clássicos de prova

Classificações e epônimos que as provas ainda cobram.

TABELA 11. O que mais cai

TEMA	PONTO DE PROVA	OBSERVAÇÃO
<i>Borrmann (gástrico avançado)</i>	I polipoide; II ulcerado com bordas nítidas; III ulcerado e infiltrativo; IV infiltrativo difuso (linite plástica)	O tipo III é o mais comum; o IV tem o pior prognóstico
<i>Siewert (junção esofagogastrica)</i>	I: centro 1–5 cm acima da junção; II: de 1 cm acima a 2 cm abaixo; III: 2–5 cm abaixo	I se comporta como esôfago; III como estômago
<i>Krukenberg</i>	Metástase ovariana com células em anel de sinete	A origem mais comum é o estômago
<i>Irmã Maria José</i>	Nódulo umbilical metastático	Implante peritoneal, não linfonodo
<i>Polipose adenomatosa familiar</i>	Gene APC; centenas a milhares de adenomas; câncer quase certo sem cirurgia	Colectomia profilática; Gardner (osteomas, tumores desmoides)
<i>Síndrome de Lynch</i>	Genes de reparo do DNA; câncer colorretal mais jovem e mais à direita; endométrio	Amsterdã (3 parentes, 2 gerações, 1 antes dos 50) sugere Lynch, mas não exclui; hoje se pesquisa MMR/MSI no tumor
<i>Pólipo de maior risco</i>	Adenoma viloso, maior que 1 cm, com displasia de alto grau	Hiperplásico pequeno do reto tem baixo risco
<i>Sinal da "maçã mordida"</i>	Estreitamento anelar e irregular no enema opaco ou no esofagograma	Sugere tumor, mas o diagnóstico é a biópsia
<i>Gastrectomia profilática</i>	Portadores da mutação do CDH1	O câncer difuso cresce sob a mucosa e escapa da endoscopia
<i>Esôfago de Barrett</i>	Metaplasia intestinal no esôfago distal	O risco relativo é alto, mas o absoluto por ano é baixo

Fontes: JGCA 2025; ASCRS 2022 e 2023; conferência com material de preparação para residência.

APÊNDICE

Referências

- Japanese Gastric Cancer Association. Japanese Gastric Cancer Treatment Guidelines 2025 (7th edition). *Gastric Cancer*. 2026;29(2):271–299.
- Al-Batran SE et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4). *Lancet*. 2019;393:1948–57.
- van Hagen P et al. Preoperative chemoradiotherapy for esophageal or junctional cancer (CROSS). *N Engl J Med*. 2012;366:2074–84.
- Hoepfner J et al. Perioperative chemotherapy or preoperative chemoradiotherapy in esophageal cancer (ESOPEC). *N Engl J Med*. 2025;392:323–35.
- Vogel JD et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the management of colon cancer. *Dis Colon Rectum*. 2022;65:148–77.
- Langenfeld SJ et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the management of rectal cancer 2023 supplement. *Dis Colon Rectum*. 2023;66:18–31.
- Instituto Nacional de Câncer. SUS adota novo exame para detectar câncer de intestino antes de sintomas. Notícia de 21/05/2026. gov.br/inca.
- Salvadalena G et al. WOCN Society and ASCRS position statement on preoperative stoma site marking for patients undergoing colostomy or ileostomy surgery. *J Wound Ostomy Continence Nurs*. 2015;42(3):249–52.
- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SAS/MS nº 400, de 16 de novembro de 2009. Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no SUS (garante bolsas, adjuvantes e acompanhamento).

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Radiology 0002 Nevit.jpg*: Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0.
- *Esophageal adenoca.jpg*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Linitis plastica.jpg*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Virchow'sNodeMark.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0.
- *Colon cancer; Stricture of colon (título original em tégulo).jpeg*: Dr. Gannavarapu Narasimhamurthy, CC0.
- *Dickdarmileus bei hochgradig stenosierendem Deszendenskarzinom 91M - CR Linksseitenlage und ap und CT koronar - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *ColonCa WithMetsMark.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0.
- *Ileostomy 2017-02-20 5349.jpg*: Salicyna, CC BY-SA 4.0.

Colostomy and parastomal hernia.JPG: Mikael Häggström, CC0.